

1. ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ขั้นตอนการถอดเปลือกสำหรับผู้มารับบริการ

2. ผลงานประเภท : CQI

3. คำสำคัญ : การถอดเปลือก

4. สรุปผลงานโดยย่อ : โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ขั้นตอนการถอดเปลือกสำหรับผู้มารับบริการ เป็นการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและผู้ปกครองก่อนเข้ารับหัตถการ การถอดเปลือก โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการให้ข้อมูลก่อนรับบริการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความพึงพอใจ ในการเข้ารับการถอดเปลือก นอกจากนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่มีสื่อวีดิทัศน์ในการสื่อสารให้ข้อมูลกับผู้มารับบริการและส่งเสริมคุณภาพการบริการในคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

- 5.1. เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการถอดเปลือก
- 5.2. เพื่อให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการถอดเปลือก
- 5.3. เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะได้รับการบาดเจ็บจากการถอดเปลือก
- 5.4. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนั้น มีผู้ป่วยเด็กมารับบริการเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลสถิติในปี พ.ศ. 2565-2568 มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ 6,219 ราย, 6,562 ราย, 6,660 ราย และ 6,269 ราย ในจำนวนนี้มีผู้รับบริการหัตถการใส่เปลือก 379 ราย, 452 ราย, 455 ราย และ 460 ราย ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีความพิการตั้งแต่กำเนิด เช่น เท้าพิการผิดปกติแต่กำเนิด ภาวะเท้าปุก และจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เปลือก เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยตามกระดูกให้เข้าที่ เพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นได้อยู่หนึ่ง ๆ เป็นการลดความเจ็บปวด ลดบวม และทำให้กระดูกหักนั้นติดกันดีเหมือนเดิม เปลือกมีอยู่ 2 ชนิดได้แก่ เปลือกปูน ทำจากปูนพลาสเตอร์มาเคลือบบนผ้าฝ้าย การตัดเปลือก ดัดเปลือกจะทำได้ง่าย และเปลือกพลาสติก ทำมาจากไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ การตัดเปลือก ดัดเปลือกทำได้ยาก โดยทั่วไปแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาตรวจซ้ำประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังใส่เปลือก เพื่อดูอาการและดูว่าเปลือกหลวมหรือไม่ ถ้าเปลือกหลวมก็อาจต้องเอกซเรย์และเปลี่ยนเปลือกให้ใหม่ ถ้าเปลือกแน่นและแข็งแรงดีอยู่ แพทย์จะนัดประเมินอาการตามดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อเอกซเรย์กระดูกจนกว่ากระดูกจะติดสนิท

การตัดเปลือก เป็นขั้นตอนทางการแพทย์ที่ทำโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเอาเปลือกออกจากการรักษา โดยใช้เครื่องมือพิเศษ คือ เลื่อยตัดเปลือก ใบเลื่อยสั้นแต่ไม่หมุน มีเสียงดังและรู้สึกร้อนจากการเสียดสี แต่จะไม่เป็นอันตราย ต้องคอยระมัดระวังมิให้กดใบเลื่อยลึกเกินความหนาของเปลือก กดใบเลื่อยเข้าไปในเนื้อเปลือก เมื่อพ้นความหนาของเปลือกจะรู้สึกว่ามีช่องว่างอยู่ใต้เปลือกให้ยกเครื่องตัดเปลือกขึ้นแล้วกดลงใหม่เป็นระยะ ตลอดแนวเปลือกที่ต้องการ ไม่ทำให้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อใต้เปลือกได้รับบาดเจ็บ

ขั้นตอนการถอดเปลือก

- | | |
|------------------|--|
| ๑. เตรียมผู้ป่วย | อธิบายขั้นตอนการถอดเปลือกให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองเข้าใจ และคลายความกังวล |
| ๒. ถอดเปลือก | แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ใช้เลื่อยตัดเปลือก โดยเลื่อยจะสั้นแต่ไม่หมุน ซึ่งช่วยป้องกันการบาดเจ็บต่อผิวหนัง กดเข้าไปในเปลือกและตัดไปตามแนวที่ต้องการ |
| ๓. แยกเปลือก | เมื่อตัดเปลือกเสร็จ เปลือกจะถูกแยกออกจากกันอย่างระมัดระวัง |

๔. ทำความสะอาด ผิวหนังบริเวณนั้นอาจแห้งและเป็นขุย ทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำ เช็ดอย่างเบา มือ อาจทาด้วยน้ำมันหรือโลชั่นเพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้น หรือในกรณีมีบาดแผลจากการ ผ่าตัด พยาบาลจะเป็นผู้ประเมินแผลและทำความสะอาดบาดแผลให้ใหม่

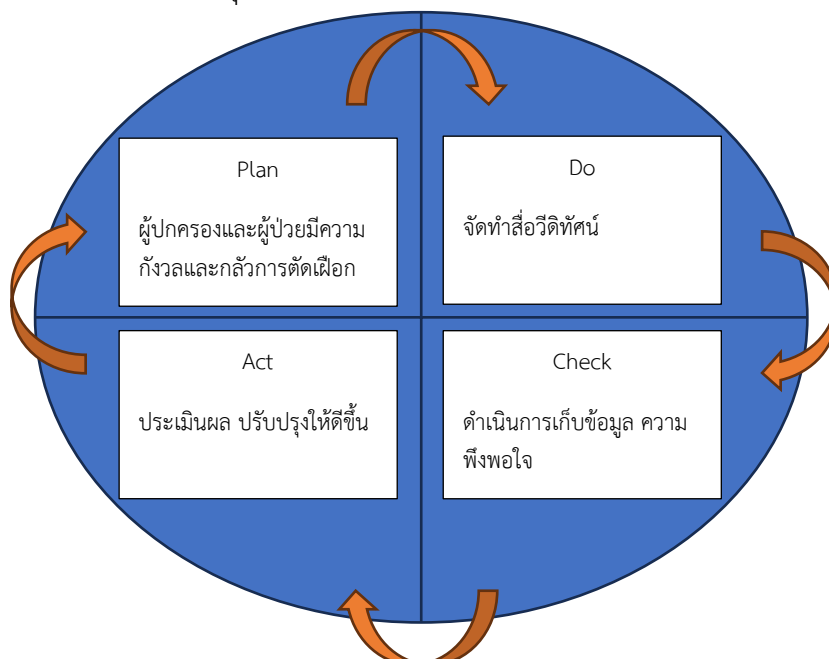
พบว่าในขณะที่ทำการถอดเฝือกทั้งผู้ป่วยและผู้ปกครองมีความวิตกกังวลและมีความกลัว ดังนั้น ความร่วมมือจึงเป็นไปค่อนข้างยาก ในบางรายผู้ป่วย ร้องให้ ดิ้น ไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้ต้องใช้เวลานาน และเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ

จากสถานการณ์ดังกล่าวคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ จึงเกิดแนวความคิดในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยและผู้ปกครองในการเข้ารับบริการถอดเฝือก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการถอดเฝือก ลดความวิตกกังวลและความกลัว ลดความเสี่ยงที่จะได้รับ บาดเจ็บ ทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ และผู้ปกครองมีความพึงพอใจ

7. กิจกรรมการพัฒนา :

- 7.1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พิจารณาปัญหาเลือกเรื่องที่จะทำโครงการ
- 7.2. กำหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
- 7.3. กำหนดแนวทางการทำสื่อวีดิทัศน์ขั้นตอนการถอดเฝือก
- 7.4. ทบทวนและวางแผนการจัดทำสื่อวีดิทัศน์
- 7.5. จัดทำสื่อวีดิทัศน์ขั้นตอนการถอดเฝือก
- 7.6. ดำเนินการเก็บข้อมูล
- 7.7. รวบรวมข้อมูลและประเมินผล
- 7.8. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569



8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

- 8.1. มีสื่อวีดิทัศน์ 1 เรื่อง
- 8.2. ผู้ป่วยได้รับการถอดเฝือกปลอดภัย มากกว่า 90 %
- 8.3. ผู้ป่วยและผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากกว่า 85 %

8.4. เจ้าหน้าที่ที่มีความพึงพอใจมากกว่า 85%

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ :

- 9.1. มีสื่อวีดิทัศน์และใช้สื่อวีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการถอดเฝือก แก่ผู้ป่วยและผู้ปกครองที่รับการถอดเฝือก 1 เรื่อง
- 9.2. ผู้ป่วยและผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการถอดเฝือกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2569 จำนวน 30 คน ไม่พบความเสี่ยงที่อาจได้รับการบาดเจ็บจากการถอดเฝือก 100 %
- 9.3. ใช้สื่อวีดิทัศน์ แนะนำขั้นตอนการถอดเฝือก แก่ผู้ป่วยและผู้ปกครองที่รับการถอดเฝือก ลดความกังวล ให้ความร่วมมือ 86.70 %
- 9.4. ผู้ป่วยและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 96.39 %
- 9.5. ความพึงพอใจรวมของเจ้าหน้าที่ 90.66 %

10. บทเรียนที่ได้รับ :

การอธิบายผู้รับบริการที่มาทำหัตถการการถอดเฝือกโดยไม่มีสื่อประกอบอาจทำให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองมีความเข้าใจการถอดเฝือกไม่ครบถ้วน ผู้ดำเนินการจึงมีการพัฒนาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ขั้นตอนการถอดเฝือก เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจขั้นตอนได้ง่ายขึ้น

การพัฒนาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ขั้นตอนการถอดเฝือก เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานบริการ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ แต่ผู้ดำเนินการได้ศึกษาวิธีการจัดทำสื่อและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมและสามารถนำมาใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้ นอกจากนี้สามารถต่อยอดจัดทำสื่อในหัตถการอื่นของคลินิก ศัลยกรรมกระดูกและข้อได้

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

นางสาวลาวัลย์	วิจารณ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณก	แพรททอง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุนันท์ทิส	วงศ์ลาวัลย์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวาสนา	ตรีธัญญา	ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายธนากรฤต	แพ่งอุ่ม	ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน	: คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	
เบอร์โทรศัพท์	: 3213 , 3214	
e-mail	: muay250846@gmail.com	